PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA

PARA INFECÇÃO HUMANA PELO

CORONAVÍRUS (COVID-19)

São Sebastião do Alto

2020

PREFEITO:
CARLOS OTÁVIO DA SILVA RODRIGUES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE:
CLAUDIANE DOS SANTOS PIETRANI RODRIGUES

COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EEPIDEMIOLÓGICA:
FERNANDA DE ALMEIDA

INTRODUÇÃO

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da OMS na China foi informado sobre casos de uma pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de Wuhan, província de Hubei. Foi identificado um novo tipo de Coronavírus, que foi isolado em 07 de janeiro de 2020, o surto estava associado a exposições em um mercado de frutos do mar em Wuhan.

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou a infecção humana pelo novo Coronavírus uma emergência em Saúde Pública de interesse internacional (ESPII).

Esta declaração tem como objetivo a preparação e resposta dos países membros na contenção e expansão de casos, ações de Vigilância Ativa, detecção precoce, gerenciamento de casos, rastreamento de contatos, prevenção e controle da expansão exponencial da infecção.

EPIDEMIOLOGIA

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos anos 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem. Os coronavírus comuns que infectam humanos são alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves, como a síndrome respiratória aguda grave que ficou conhecida pela sigla SARS da síndrome em inglês “Severe Acute Respiratory Syndrome”. SARS é causada pelo coronavírus associado à SARS (SARS-CoV), sendo os primeiros relatos na China em 2002. O SARS-CoV se disseminou rapidamente para mais de doze países na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, infectando mais de 8.000 pessoas e causando entorno de 800 mortes, antes da epidemia global de SARS ser controlada em 2003. Desde 2004, nenhum caso de SARS tem sido relatado mundialmente.

Os coronavírus são de uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelo, gado, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre pessoas como MERS-CoV e SARS-CoV. No início, muitos dos pacientes com surtos de doenças respiratórias causadas por 2019-nCov em Wuhan, na China, tinham alguma ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais vivos, sugerindo a disseminação de animais para pessoas. No entanto, um crescente número de pacientes, supostamente não teve exposição ao mercado, indicando a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa.

O período médio de incubação da infecção por Coronavírus é de 5 dias, podendo chegar até 16 dias. A transmissibilidade dos infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias após o início dos sintomas. Estudos sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste novo coronavírus não está estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais investigações e tempo para caracterização da doença. Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. Em avaliação recente de 99 pacientes com pneumonia e diagnóstico laboratorial de COVID-19 internados no hospital de Wuhan, aponta-se maior taxa de hospitalização em maiores de 50 anos, sexo masculino. Os principais sintomas foram febre (83%), tosse (82%), falta de ar (31%), dor muscular (11%), confusão (9%), dor de cabeça (8%), dor de garganta (5%), rinorréia (4%), dor no peito (2%), diarréia (2%) e náusea e vômito (1%).

Segundo exames de imagem, 74 pacientes (75%) apresentaram pneumonia bilateral, 14 pacientes (14%) apresentaram manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco e 1 paciente (1%) evoluiu com pneumotórax 7. Também houve registros de linfopenia em outro estudo realizado com 41 pacientes diagnosticados com COVID-19 8.

Em um outro estudo, finalizado no início de fevereiro de 2020, foram analisados de maneira retrospectiva 9 , 138 pacientes hospitalizados em Wuhan, na China, este pacientes foram diagnosticados com pneumonia pelo COVID-19. A idade média foi de 56 anos (intervalos de 42-68 Boletim Epidemiológico – COE COVID-19 – 21/02/2020 8 anos e 22-92 anos) e 54,3% (75/138) dos pacientes eram do sexo masculino.

Houve suspeita de transmissão hospitalar entre pacientes (40) e profissionais de saúde (17). Os sintomas mais observados incluíram febre (98,6%), fadiga (69,6%) e tosse seca (59,4%). Na tomografia computadorizada do tórax observou-se opacidade em vidro fosco de todos os pacientes. Em relação ao tratamento, 89,9% (124) recebeu o antiviral fosfato de oseltamivir, e também foram medicados com antibacterianos (64,4% (89) com moxifloxacina; 24,6% (34) ceftriaxona; 18,1% (25) azitromicina) e 44,9% (62) usaram terapia com glicocorticoides.

Entre os pacientes 26,1% (36) tiveram complicações e foram transferidos para unidade de terapia intensiva (UTI), principalmente por síndrome do desconforto respiratório agudo

(SDRA) (61,1% (22)), por arritmia (44,4% (16)) e choque (30,6 % (11)). A mediana entre o início dos sintomas (IS) e a dispneia foi de 5 dias, entre o IS e a admissão hospitalar foi de 7 dias e o IS e a SDRA foi de 8 dias. Em 72,2% (26) dos pacientes de UTI foi observado comorbidades, em relação a 19,6% (20) dos hospitalizados em leito comum.

Até o final do estudo, 34,1% dos pacientes haviam recebido alta hospitalar e 6 evoluíram ao óbito, os demais seguiam hospitalizados. Entre os que receberam alta, a mediana de dias de internação foi de 10 dias 9. Complicações As complicações mais comuns são Síndrome Respiratória Aguda Grave.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Para o diagnóstico laboratorial o espécime preferencial é a secreção da nasofaringe (SNF). Considerando novos vírus ou subtipos virais em processos pandêmicos, ele pode ser estendido até o 7º dia (mas preferencialmente, até o 3º dia).

DEFINIÇÕES OPERACIONAIS

- **CASOS SUSPEITOS**

  SITUAÇÃO 1: Febre **E** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) **E** histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas, **OU**

  SITUAÇÃO 2: Febre **E** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento de asas nasais entre outros) **E** histórico de contato próximo de **caso** suspeito para o Coronavírus, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas; **OU**

  SITUAÇÃO 3: Febre **E** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento de asas nasais entre outros) **E** contato próximo de **caso** confirmado de Coronavírus em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas.

- **CASO PROVÁVEL**

  Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para 2019-nCoV ou com teste positivo em ensaio de pan-coronavírus.

- **NOTIFICAÇÃO IMEDIATA**

  Deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento do caso que se enquadre na definição de suspeito, ao CIEVS do município do Rio de Janeiro e/ou Vigilância em Saúde local (DVS e SVS/CAP).

ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Organização do fluxo assistencial dos casos prováveis de CORONAVÍRUS;
- Notificação de casos suspeitos;
- Investigação epidemiológica de casos notificados, surto e óbitos;
- Busca ativa de casos;
- Coleta e envio aos laboratórios de referência de amostras clínicas de suspeitos para diagnóstico;
- Alimentação de sistemas de notificação;
- Divulgação de boletins epidemiológicos;
- Gestão de estoques municipais de insumos padrão;
- Educação em saúde;
- Capacitação de profissionais;

As ações de contingência são suplementares aquelas que já são realizadas na rotina e devem ser adotadas no caso de ocorrência de sinistro ou algum impedimento relevante que venha comprometer o funcionamento normal da instituição.

OBJETIVOS GERAIS

- Promover o controle e a prevenção da alta transmissão do Coronavírus entre residentes do município de São Sebastião do Alto;

- Reduzir a ocorrência de óbitos evitáveis por Coronavírus entre residentes do município de São Sebastião do Alto;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Organizar ações de prevenção e controle do Coronavírus;
- Providenciar insumos estratégicos e priorizar equipamentos necessários;
- Aprimorar a Vigilância Epidemiológica, garantindo a detecção, notificação, investigação, monitoramento e controle de pacientes detectados;
- Traçar estratégias para reduzir a transmissão da doença, monitorando e controlando pacientes já detectados;
- Promover e apoiar a capacitação de profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento da pandemia;
- Promover assistência adequada aos pacientes, garantindo todos os serviços necessários para o diagnóstico e manejo clínico adequado para a doença;
- Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação implementadas;
- Instituir a articulação de diferentes áreas e serviços, visando assim o sucesso das ações de enfrentamento;
- Reforças as ações de articulação intersetorial;
- Orientar a utilização adequada das medidas de prevenção e controle disponíveis.

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

- **TRANSPORTE SANITÁRIO:**
  O município de São Sebastião do Alto dispõe de 2 vans e 10 carros de passeio modelo Siena para transporte de pacientes.

- **UNIDADE DE SAÚDE PARA REFERÊNCIA DE PACIENTES:**
  O município de São Sebastião do Alto dispõe de um hospital – Hospital São Sebastião

- **EPI E INSUMOS NAS UNIDADES DE SAÚDE:**
  Álcool gel, máscaras cirúrgicas descartáveis e máscaras N95 para os profissionais de saúde. **Não temos nenhum!!!!**

- **UNIDADES DE SAÚDE COM PROTOCOLODE DEFINIÇÃO DE CASO:**
  100% das Unidades de Saúde com protocolo estabelecido. (em anexo)

- **PROFISSIONAIS TREINADOS PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA NA ABORDAGEM DE CASOS SUSPEITOS, PROVÁVEIS E CONFIRMADOS:**
  Todos os profissionais receberam orientações para um atendimento qualificado e eficaz em 100% das Unidades.

- **AÇÕES DE INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL:**
  Um Decreto Municipal foi feito e distribuído à população juntamente com informações a respeito do Coronavírus. Como está proibido reuniões e as aulas estão suspensas, não foi possível realizar nenhum tipo de ação educativa com a população presente, mas foram postados vídeos explicativos e folders na página oficial da Prefeitura Municipal no Facebook.